

Criterios de Necesidad Médica

DOC3 · Versión 1.0 · Fecha de expedición: 2026-06

Documento de carácter ilustrativo, elaborado con fines exclusivos de una prueba técnica. Su estructura y terminología se basan en fuentes de dominio público sobre el sistema de salud colombiano —entre ellas el Plan de Beneficios en Salud con cargo a la UPC y la regulación de planes voluntarios de salud del Ministerio de Salud y Protección Social—, así como en prácticas habituales de medicina prepagada. No corresponde a una entidad real ni sustituye ningún contrato, póliza o condicionado vigente.

1. Objeto y principios generales

Este documento define los criterios bajo los cuales un servicio o procedimiento se considera clínicamente procedente. La necesidad médica es condición para que un servicio cubierto (DOC1) que cumple carencia y autorización (DOC2) sea efectivamente reconocido. Un servicio se considera médicamente necesario cuando cumple, de forma concurrente, los siguientes principios:

- Está prescrito por el profesional tratante competente para la condición del afiliado.
- Es apropiado para el diagnóstico o síntoma y consistente con la buena práctica clínica y la evidencia disponible.
- No se solicita principalmente por conveniencia del afiliado, del prestador o del cuidador.
- Corresponde a la alternativa efectiva de menor complejidad y costo razonable disponible.
- Cuenta con el soporte clínico que documenta la indicación (historia clínica, resultados previos, evolución).

2. Criterios por tipo de servicio

2.1 Imágenes diagnósticas de alta complejidad

Para resonancia magnética (RM), tomografía (TAC) o PET se exige, además de la prescripción del especialista:

1. Existencia de un cuadro clínico que lo justifique, documentado en la historia clínica.
2. Manejo conservador previo cuando aplique (por ejemplo, en patología osteomuscular no aguda, mínimo 4 a 6 semanas de tratamiento inicial sin mejoría), salvo signos de alarma.
3. Que estudios de menor complejidad (por ejemplo, radiografía o ecografía) hayan resultado insuficientes o no concluyentes, o que estén clínicamente contraindicados.
4. Ausencia de un estudio equivalente reciente que responda a la misma pregunta clínica.

Ejemplo — RM de rodilla: procede cuando el especialista la prescribe ante dolor o inestabilidad persistente pese a manejo conservador de al menos 4–6 semanas, o ante sospecha de lesión meniscal o ligamentaria no aclarada por radiografía. Existen signos de alarma (bloqueo articular, trauma agudo con derrame, sospecha de infección o tumor) que permiten omitir el manejo conservador previo.

2.2 Procedimientos y cirugías electivas

1. Diagnóstico confirmado que constituya indicación quirúrgica reconocida.
2. Agotamiento razonable de alternativas no quirúrgicas cuando estén indicadas.
3. Valoración preoperatoria y concepto favorable del especialista tratante.
4. Relación beneficio/riesgo favorable documentada.

2.3 Terapias de rehabilitación

1. Prescripción con diagnóstico funcional y objetivo terapéutico definido.
2. Plan con número de sesiones estimado y evaluación periódica de resultados.
3. Suspensión cuando se alcanzan los objetivos o no hay respuesta tras un ciclo razonable.

2.4 Hospitalización

1. Condición clínica que no pueda manejarse de forma ambulatoria de manera segura.
2. Necesidad de monitoreo, tratamiento o procedimientos que exijan entorno hospitalario.
3. La hospitalización programada requiere autorización previa (DOC2); la urgente no.

2.5 Medicamentos de alto costo

1. Diagnóstico confirmado y agotamiento de alternativas de primera línea cuando existan.
2. Prescripción por especialista y ajuste a las indicaciones aprobadas.
3. Seguimiento de respuesta clínica y criterios de continuación o suspensión.

3. Signos de alarma (excepción al manejo conservador)

Ante la presencia de signos de alarma, algunos requisitos escalonados (como el manejo conservador previo) pueden omitirse por la premura clínica. Se consideran signos de alarma, entre otros:

- Trauma agudo significativo con impotencia funcional o derrame.
- Sospecha de proceso infeccioso, tumoral o neurológico progresivo.
- Déficit neurológico, pérdida de fuerza o compromiso de esfínteres.
- Dolor incoercible o deterioro clínico rápido.

4. Relación con la decisión de cobertura

La necesidad médica no reemplaza las demás condiciones del plan. Un servicio médicamente necesario que esté excluido (DOC2, numeral 5) no se cubre; y un servicio cubierto y necesario cuya carencia no se ha cumplido o que carece de autorización vigente se reconoce como 'cubierto con condiciones', indicando expresamente qué debe subsanarse. La decisión final debe fundamentarse citando el documento y el numeral que la sustentan.